

Niệu động học (urodynamics) là một nhóm xét nghiệm đo khả năng chứa và thải nước tiểu của bàng quang. Các ống thông mềm, mảnh (cảm biến áp lực) được đặt vào trong khi bàng quang từ từ được làm đầy rồi làm trống. Mục tiêu là tái hiện lại các triệu chứng của bạn ngay tại phòng khám để nhóm chăm sóc xác định đúng nguyên nhân và lập kế hoạch điều trị phù hợp.

Về xét nghiệm này

Niệu động học không phải một mà gồm nhiều xét nghiệm thực hiện cùng nhau. Tùy nhu cầu, có thể bao gồm:

- **Đo dòng tiểu** — bạn tiểu vào bồn đặc biệt đo tốc độ dòng tiểu, sau đó nhóm chăm sóc kiểm tra lượng nước tiểu còn lại.
- **Nghiên cứu làm đầy** — bàng quang được làm đầy từ từ trong khi đo áp lực và bạn báo cáo cảm giác của mình.
- **Nghiên cứu áp lực-dòng tiểu** — đo áp lực trong khi bạn đi tiểu.
- Đôi khi **chụp X-quang** được thực hiện đồng thời (niệu động học video).

Hai ống thông mảnh được dùng: một đặt vào bàng quang (qua niệu đạo) và một ống rất nhỏ đặt vào trực tràng (hoặc âm đạo) để đo áp lực ổ bụng, giúp phân biệt áp lực bàng quang với áp lực do rặn.

Có an toàn không?

Có. Niệu động học là xét nghiệm ít rủi ro và có tính tương tác. Rủi ro chính đến từ ống thông — cảm giác nóng rát nhẹ và nguy cơ nhỏ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Bạn có thể được cho dùng kháng sinh. Không cần phẫu thuật và không cần thời gian hồi phục.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu động học

Nhóm xét nghiệm đo cách bàng quang chứa và thải nước tiểu.

Bàng quang

Túi cơ chứa nước tiểu cho đến khi bạn đi tiểu.

Ống thông (catheter)

Ống mềm, mảnh dùng để làm đầy bàng quang và đo áp lực.

Nghiên cứu làm đầy

Đo áp lực và cảm giác khi bàng quang từ từ được làm đầy.

Nghiên cứu áp lực-dòng tiểu

Đo áp lực trong khi tiểu để đánh giá khả năng làm trống bàng quang.

Đo dòng tiểu

Đo tốc độ và hình dạng dòng tiểu của bạn.

Niệu động học video

Xét nghiệm tương tự kết hợp chụp X-quang để có thêm thông tin.

Nước tiểu tồn dư sau tiểu

Lượng nước tiểu còn lại trong bàng quang sau khi đi tiểu.

CÓ ĐAU KHÔNG? Hầu hết mọi người cảm thấy áp lực và đôi chút ngại ngùng do ống thông hơn là đau thực sự. Bạn sẽ được yêu cầu ho, thay đổi tư thế và đi tiểu trong lúc xét nghiệm — nhóm chăm sóc sẽ đảm bảo sự riêng tư và làm theo nhịp của bạn. Xét nghiệm thường kéo dài khoảng 30–60 phút và bạn có thể về nhà ngay sau đó.

Cách chuẩn bị (Trước xét nghiệm)

- Bạn có thể được yêu cầu đến với **bàn quang đầy vừa phải** — hãy làm theo hướng dẫn được cung cấp.
- Uống **thuốc thường ngày** như bình thường, nhưng hỏi xem có cần **ngừng thuốc bàn quang** nào trước không, vì chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả.
- Không cần an thần, nên bạn thường có thể **tự lái xe về nhà**.

Hãy báo trước cho nhóm chăm sóc nếu bạn:

- Có dấu hiệu **niễm trùng đường tiết niệu** (nóng rát, sốt, hoặc nước tiểu đục, có mùi nặng) — nhiễm trùng đang hoạt động có thể khiến xét nghiệm cần dời lại
- Đang dùng thuốc loãng máu, hoặc có dị ứng bất kỳ (kể cả dị ứng latex)

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp **mẫu nước tiểu** để kiểm tra nhiễm trùng trước xét nghiệm.

Quá trình xét nghiệm

- 1 Bạn tiểu vào bồn đặc biệt đo dòng tiểu, sau đó nhóm chăm sóc kiểm tra lượng nước tiểu còn lại.
- 2 Các ống thông mảnh được đặt nhẹ nhàng — một vào bàn quang và một ống nhỏ vào trực tràng hoặc âm đạo.
- 3 Bàn quang được làm đầy từ từ trong khi bạn báo cáo khi nào cảm thấy đầy lần đầu và khi nào có cảm giác tiểu gấp; bạn có thể được yêu cầu ho hoặc thay đổi tư thế.
- 4 Bạn đi tiểu trong khi áp lực được ghi lại, sau đó các ống thông được rút ra.

Sau xét nghiệm

- Bạn có thể **trở lại sinh hoạt bình thường ngay**.
- Bạn có thể cảm thấy **nóng rất nhẹ khi tiểu** trong một ngày. Uống nhiều nước giúp giảm bớt cảm giác này.
- Nước tiểu có thể có **màu hồng nhạt** trong thời gian ngắn. Điều này thường gặp và thường hết trong vòng một ngày.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Khó tiểu, hoặc hoàn toàn không tiểu được
- Chảy máu nhiều, hoặc có cục máu đông trong nước tiểu
- Đau ngày càng nặng hơn thay vì giảm

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Niệu động học đo cách bàn quang làm đầy và làm trống để nhóm chăm sóc tìm ra nguyên nhân gây rò rỉ, tiểu gấp hoặc khó đi tiểu — và lên kế hoạch điều trị đúng.
2. Chuẩn bị rất đơn giản: hỏi xem có cần ngừng thuốc bàn quang không, đến với bàn quang đầy vừa phải nếu được yêu cầu, và báo cho nhóm chăm sóc biết nếu có dấu hiệu nhiễm trùng.
3. Hãy chuẩn bị cho cảm giác áp lực nhiều hơn là đau, và về nhà ngay sau đó. Nóng rất nhẹ hoặc nước tiểu hơi hồng trong một ngày là bình thường — uống thêm nước, và gọi cho bác sĩ nếu sốt, chảy máu nhiều hoặc không tiểu được.